

# Bloom

Skrypt prezentacji i źródła

*Ruch po porodzie, w Twoim tempie*

Patrycja Jaworska, Krzysztof Żybura, Karol Dziekan, Karol Peszek, Jan Bil

## Problem

### 1. Tytuł

Startujemy w kategorii ImpactHer: Technology for Real Change. Chcemy opowiedzieć o okresie w życiu kobiety, o którym mówi się zaskakująco mało.

### 2. „Idealna ciąża”: luksus nie dla każdej

Na ciążę kobieta przygotowuje się dziewięć miesięcy. Są badania, szkoły rodzenia, aplikacje, które tydzień po tygodniu mówią, jak rośnie dziecko.

A potem przychodzi poród. I na to, żeby wrócić do siebie, kobieta dostaje zwykle jedną wizytę kontrolną.

Wszyscy pytają, jak się czuje maluch. Mało kto pyta, jak czuje się mama. Dla wielu kobiet właśnie ten czas, dochodzenie do siebie po porodzie, okazuje się najtrudniejszy.

I to nie są pojedyncze historie. Mniej więcej co trzecia kobieta zмага się z nietrzymaniem moczu w pierwszym roku po porodzie.<sup>[1]</sup>

U około sześćdziesięciu procent sześć tygodni po porodzie mięśnie brzucha wciąż są rozdzielone.<sup>[2]</sup>

A w Polsce prawie co drugi poród to cesarskie cięcie, czyli operacja, po której ciało potrzebuje czasu.<sup>[3]</sup>

To jest norma. Tylko że o tej normie się nie mówi, bo to tematy wstydlive.

Gdzie więc kobiety szukają odpowiedzi? Najczęściej w telefonie. A tam widzą takie obrazy: trening z ciężarami kilka tygodni po porodzie, płaski brzuch, dziecko bawiące się obok i hasło, że wystarczy chcieć.

Rzeczywistość wygląda inaczej. Cztery godziny snu, i to w kawałkach. Blizna, która ciągnie przy każdym wstawaniu. Popuszczanie przy kaszlu.

Takie obrazy nie motywują. Sprawiają, że kobiety czują, że coś jest z nimi nie tak. Albo próbują dogonić ideał, wracają do treningów za szybko i robią sobie krzywdę.

## Rozwiązanie

### 3. Bloom i ankieta na start

Dlatego stworzyliśmy Bloom. To aplikacja, która prowadzi kobietę przez bezpieczny powrót do aktywności po porodzie, w jej własnym tempie.

Opiera się na trzech filarach. Po pierwsze: plan, który słucha ciała, a nie kalendarza. Po drugie: most do specjalisty, czyli lepiej wykorzystana wizyta u lekarza czy fizjoterapeutki. Po trzecie: krąg wsparcia, czyli bliscy, którzy wiedzą, jak pomóc.

Nowa użytkowniczka przechodzi krótką ankietę w czterech krokach. Najpierw poród: jak prze-

biegał, bo po cesarskim cięciu i po porodzie z nacięciem krocza bezpieczne są inne ćwiczenia. Do tego data porodu, z której aplikacja sama liczy, na jakim etapie regeneracji jest kobieta.

Potem ruch: jak aktywna była przed ciążą, co lubi robić i jaki ma cel. Nasza persona, Kasia, chce wrócić do biegania. Trzeci krok to dolegliwości. Piszemy wprost: to częste po porodzie i nie ma się czego wstydzić. Ból blizny, nietrzymanie moczu, przewlekłe zmęczenie. Te dane widzi tylko ona.

Czwarty krok to bezpieczeństwo: czy była już na wizycie kontrolnej i czy lekarz dał jakieś zalecenia. Plan uwzględnia te odpowiedzi.

Na tej podstawie Kasia, która jest w 8. tygodniu po porodzie, dostaje gotowy plan: trzy sesje po piętnaście minut tygodniowo, skupione na dnie miednicy, mięśniach głębokich i oddechu. Bieganie odblokuje się dopiero po testach gotowości, około dwunastego tygodnia, zgodnie z wytycznymi dla fizjoterapii poporodowej.<sup>[6]</sup> Mama, która jest dopiero w połogu, zaczyna od spacerów i oddechu. Każda kobieta zaczyna więc tam, gdzie jest, a nie tam, gdzie według kalendarza „powinna” być.

#### 4. Everyday routine

Tak wygląda codzienność w Bloom. Każdego dnia kobieta robi piętnastosekundowy check-in: jak się czuje, ile ma energii, jak spała, czy coś boli.

I tu jest sedno: plan dopasowuje się do dnia. Kasia mało dziś spała, więc aplikacja skraca sesję i pomija ćwiczenia w podporze. I mówi jej to wprost, wyjaśniając dlaczego.

Na ekranie cały czas widać też przycisk STOP. Opowiemy o nim za chwilę.

#### 5. Ćwiczenia z AI

Dlaczego w ogóle ruch? Bo badania pokazują jasno, że po porodzie naprawdę pomaga. Aktywne mamy mają o około połowę mniejsze ryzyko depresji poporodowej.<sup>[4]</sup> Już po czterech do ośmiu tygodniach regularnego ruchu kobiety czują wyraźnie mniej zmęczenia, lęku i smutku.<sup>[5]</sup> A żeby to zaczęło działać, wystarczy około jedenastu minut dziennie.<sup>[4]</sup> Mniej niż jedna drzemka dziecka. Jest tylko jeden warunek: ruch musi być dopasowany do etapu i do konkretnego ciała.

Po lewej dzisiejsza sesja Kasi. Przy każdym ćwiczeniu jest krótkie wyjaśnienie, dlaczego jest bezpieczne na jej etapie, a wykonane ćwiczenia odhacza na bieżąco.

Po prawej tryb ćwiczenia z AI. Animacja pokazuje dokładnie, jak wykonać ruch, i podpowiada oddech. W trybie kamery AI analizuje postawę i koryguje ją na żywo, na przykład „cofnij biodra, kolana nad stopami”.

Wybraliśmy przysiad do krzesła nieprzypadkowo. To dokładnie ten ruch, którym mama kilkadziesiąt razy dziennie podnosi dziecko z łóżeczka. Uczymy ruchu, który przydaje się w życiu, a nie tylko na macie.

#### 6. Niepokojące objawy?

A co, jeśli coś jest nie tak? Na każdym ekranie jest przycisk STOP. Po jego naciśnięciu ćwiczenie się zatrzymuje, a kobieta widzi spokojny komunikat i listę sygnałów alarmowych, przy których trzeba skontaktować się z lekarzem: obfite krwawienie, gorączka, problem z blizną, ból w klatce piersiowej.

Jednym kliknięciem może zadzwonić na 112 albo do swojego lekarza. A bliscy z jej kręgu wsparcia od razu dostają powiadomienie.

Bloom wspiera, ale nie zastępuje lekarza. Dlatego bezpieczeństwo jest wbudowane w każdy ekran.

## Most do specjalisty

### 7. Raport na wizytę

Drugi filar to most do specjalisty. Zaczniemy od tego, jak wygląda prawdziwe życie. Wizyta trwa kilkanaście minut, a w głowie mamy jest wszystko naraz: dziecko, dom, brak snu. Pytania, które chodziły jej po głowie przez dwa tygodnie, w gabinecie po prostu znikają.

Dlatego przed wizytą Kasia w kilka sekund przygotowuje raport. Wybiera, dla kogo jest, na przykład dla fizjoterapeutki, z jakiego okresu i co ma się w nim znaleźć. Dopisuje też pytania, które przychodziły jej do głowy przez ostatnie tygodnie.

Tak wygląda raport, który dostaje specjalista. Na pierwszej stronie podsumowanie: sesje, minuty ruchu, średnie samopoczucie, wykres z codziennych check-inów i dolegliwości razem z trendem. Na drugiej zdarzenia STOP z opisem, wykonane ćwiczenia z uwagami pacjentki, jej pytania i miejsce na notatki.

Lekarz w minutę widzi dane z dwóch tygodni. A trudne tematy, jak nietrzymanie moczu, są już na papierze, więc łatwiej je poruszyć.

## Krąg wsparcia

### 8. Pełny dostęp i ograniczony

Trzeci filar to krąg wsparcia. Regeneracja po porodzie to nie coś, przez co kobieta powinna przechodzić sama. Partner, siostra, mama. Bliscy chcą pomóc, ale często nie wiedzą jak, ani co się właściwie dzieje. Do aplikacji dołączają tylko na zaproszenie mamy.

W Bloom to kobieta decyduje, kto i co widzi. Po lewej Tomek z pełnym dostępem: widzi samopoczucie Kasi z ostatnich dni, postęp ćwiczeń, etap regeneracji i raport przed wizytą.

Po prawej ten sam Tomek z ograniczonym dostępem. Widzi tylko, jak Kasia się dziś czuje, i odpowiedź, na co uważać na tym etapie. Ćwiczenia i raporty zostają prywatne.

Minimalna opcja to same powiadomienia STOP. Dostęp można zmienić albo odebrać w każdej chwili. Prywatność i kontrola są po stronie kobiety.

## Zakończenie

### 9. Dziękujemy za uwagę

Dziękujemy. Bloom: ruch po porodzie, w Twoim tempie. Chętnie odpowiemy na Wasze pytania.

## Wykorzystanie AI i zewnętrznych zasobów

Zgodnie z regulaminem HackYeah informujemy, że przy projekcie korzystaliśmy z narzędzi sztucznej inteligencji (Claude, Anthropic). AI wspierało nas przy: burzy mózgów i doprecyzowaniu pomysłu, wyszukiwaniu i weryfikacji statystyk w badaniach naukowych, projektowaniu makiet ekranów i klikalnego prototypu aplikacji, przygotowaniu logo, animacji ćwiczenia oraz przykładowego raportu PDF, a także przy redagowaniu tekstów: opisu projektu, scenariusza prezentacji i treści w aplikacji.

Wszystkie decyzje dotyczące koncepcji, funkcji, grupy docelowej i kształtu produktu podejmował zespół, który rozumie i potrafi uzasadnić każdy element rozwiązania. Wszystkie elementy powstały podczas hackathonu.

Statystyki pochodzą z publikacji naukowych i źródeł branżowych wymienionych poniżej.

## Źródła

1. Urinary incontinence 6 weeks to 1 year post-partum (PMC)  
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8295159>
2. Diastasis recti abdominis prevalence (PMC)  
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5013086>
3. Odsetek cięć cesarskich sięga już 48 proc. (Rynek Zdrowia)  
<https://www.rynekzdrowia.pl/Badania-i-rozwoj/Odsetek-ciec-cesarskich-siega-juz-48-proc-Badaczki-sprawdzaja-jak-ograniczyc-te-liczbe,281313,11.html>
4. Deprato i in., British Journal of Sports Medicine 2024 (omówienie)  
<https://www.obgproject.com/2024/11/27/meta-analysis-does-exercise-improve-symptoms-of-postpartum-depression-and-anxiety/>
5. Exercise and maternal depression, anxiety, fatigue: meta-analysis (PMC)  
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11608960/>
6. Goom, Donnelly, Brockwell 2019: Returning to running postnatal  
[https://www.researchgate.net/publication/335928424\\_Returning\\_to\\_running\\_postnatal\\_-\\_guidelines\\_for\\_medical\\_health\\_and\\_fitness\\_professionals\\_managing\\_this\\_population](https://www.researchgate.net/publication/335928424_Returning_to_running_postnatal_-_guidelines_for_medical_health_and_fitness_professionals_managing_this_population)